

Gestão de Planos de Saúde

MILENA BARBOSA DE MELO
CRISTINA SPENGLER AZAMBUJA



Unidade 2

Livro Didático
Digital



Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial
ANDRÉA CÉSAR PEDROSA

Projeto Gráfico
MANUELA CÉSAR ARRUDA

Autoras
MILENA BARBOSA DE MELO
CRISTINA SPENGLER AZAMBUJA

Desenvolvedor
CAIO BENTO GOMES DOS SANTOS

AS AUTORAS

MILENA BARBOSA DE MELO E CRISTINA SPENGLER AZAMBUJA

Eu, Milena, possuo graduação em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba (2004). Doutora em Direito Internacional pela Universidade de Coimbra. Mestre e Especialista em Direito Comunitário pela Universidade de Coimbra. Atualmente sou Professora Universitária da Universidade Estadual da Paraíba e Conteudista. Diretora acadêmica da Agência Nacional de Estudos em Direito ao desenvolvimento (ANEDD). Como jurista atuo principalmente nas seguintes áreas: Direito à Saúde, Direito Internacional público e privado, Jurisdição Internacional, Direito Empresarial, Direito do Desenvolvimento, Direito da Propriedade Intelectual e Direito Digital

Eu, Cristina, sou Consultora Organizacional e Coaching Executiva. Graduada em História e Mestre em Ciências Humanas pela UNISINOS (SL-2006), especialista em Pedagogia Empresarial pela FEEVALE (NH-2010), especialista em Psicologia Organizacional (ESADE-PA), especialista em Educação à Distância, com ênfase e docência e tutoria em EAD (PUC-RS), Member Coach pela Associação Latino Americana de Coaching (SLAC-SP-2013), credenciada PMI (projetos), certificada Analista Comportamental DISC, professora convidada no MBA de Gestão de Pessoas da FAPA, FEEVALE e UNISINOS, consultora organizacional especializada em educação corporativa, desenvolvimento de equipes, inovação e liderança. Bolsista PIBIC (2000/2002), CNPQ (2011), Projeto: Inserção de mestres e doutores na indústria para promoção da Inovação. Professora orientadora e tutora do CERFEaD, Instituto Federal de Santa Catarina no curso de pós-graduação em Gestão pública, consultora externa da FIERGS nos programas de Inovação e Consultoria para Educação de Qualidade, atuando na formação em gestão de equipes diretivas de escolas no estado do Rio Grande do Sul e no programa Educação para o mundo do trabalho. Voluntária em projetos de orientação profissional e preparação para o trabalho com jovens em situação de vulnerabilidade social. Experiência de mais de 15 anos coordenando projetos em empresas de diversos segmentos na área de EDUCAÇÃO CORPORATIVA (EPCOS/TDK, PIRELLI, COSMOBEL BEAUTY STORE, BALAS FLORESTAL, CAMERA GRÃOS, WDS PNEUMÁTICOS, SACOPLAST, TRAMONTINA, TINTAS KILLING, FATI FERRAMENTAS, LABORATÓRIO DO PÉ – BRASIL, etc.), instituições (FIERGS/SESI/SEBRAE/SEDAE) e prefeituras (CAXIAS DO SUL, ESTÂNCIA VELHA, PAULO BENTO, PINHEIRO MACHADO, SÃO LEOPOLDO, ETC.).

Desse modo, fomos convidadas pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estamos muito felizes em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte conosco!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Meu nome é Manuela César de Arruda. Sou a responsável pelo projeto gráfico de seu material. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



INTRODUÇÃO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;



EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;



ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;



IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;



RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Características do Mercado de Saúde Suplementar	11
Fundamentos Conceituais do Mercado de Saúde Suplementar.....	11
Histórico e Fundamentação dos Planos de Saúde no Brasil.....	19
Trajetória dos Planos de Saúde no Brasil.....	22
Mudanças Políticas na Saúde Brasileira.....	23
Modalidades de Operadoras e Resultados Econômicos	28
Marco Regulatório Setorial (1985-1998) – Implantação da Saúde Universal e Consolidação do Mercado Suplementar.....	33

UNIDADE

02

LIVRO DIDÁTICO DIGITAL

INTRODUÇÃO

A partir da Constituição de 1988 o atual sistema de saúde do Brasil, a saúde é garantida e descrita como um direito a todos brasileiros. Fica sob incumbência de o Estado dar a assistência pública que vai desde a regulação das práticas médicas à prestação da assistência médica e hospital. Todas essas ações embasadas por políticas sociais e econômicas e divididas em dois subsistemas: Público ou privado.

Em relação ao subsistema público, o Sistema Único de Saúde SUS é a instituição que garante o atendimento médico universal dos brasileiros. A implantação do SUS representou para o Brasil uma extensão médica expressiva aos usuários. A partir de sua criação, a assistência médica do Estado não fica mais condicionada ao vínculo empregatício do trabalhador. A partir disso, a saúde é garantida a todos.

Sobre o segundo subsistema, o privado, ele é dividido em dois subsetores:

- Saúde suplementar: composta pelos serviços financiados pelos planos de saúde e seguros.
- Subsetor liberal clássico: composto por serviços autônomos particulares com clientela própria.

Esses subsistemas possuem subsídios públicos, mas com financiamento privado, a gestão também é privada, mas regulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Os prestadores de serviços em saúde são privados e credenciados pelos planos de saúde ou cooperativas médicas. Podem também, ainda serem contratados pelo sistema público de empresas credenciadas a prestarem serviços ao Estado.

Chama-se no Brasil, suplementar o setor de planos de saúde, devido a alternativa de pagar um seguro e assistência médica privada, mas que também garante a assistência ao serviço médico público. Contudo, também poderia ser chamado de complementar devido a ideia de que é utilizado quando o sistema público limita o usuário devido sua má qualidade de gestão ou recursos. Nesse caso, o plano privado realiza o complemento da assistência que o sistema público não provém.

Diante disso, é correto afirmar que no Brasil, a atenção a saúde é atendida na sua grande maioria pelo Sistema Único de Saúde. Mesmo com suas dificuldades e ineficiência é o SUS o grande responsável pela saúde e seguridade dos brasileiros. Suas fragilidades oportunizaram aos planos de saúde um mercado rentável e em crescimento contínuo.

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 2. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Compreender o histórico das políticas de saúde no Brasil.
2. Identificar as etapas dos processos relacionados à saúde suplementar
3. Identificar o sistema de saúde brasileiro e seus desdobramentos históricos.
4. Executar uma análise contextualizada em relação a saúde pública brasileira e os inícios da intervenção da saúde suplementar brasileira.

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? Ao trabalho!

“Os resultados são obtidos através da exploração de oportunidades, não pela solução de problemas.” Peter Drucker

Características do Mercado de Saúde Suplementar

OBJETIVO



Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona os fundamentos e características do mercado de saúde suplementar brasileira. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram praticar gestão na área da saúde sem a devida instrução tiveram problemas ao desempenhar suas atividades. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Fundamentos Conceituais do Mercado de Saúde Suplementar

OBJETIVO



No final deste capítulo você deverá ter aprendido a respeito dos fundamentos conceituais do mercado de saúde suplementar, além de ter maior conhecimento sobre a sua prática, bem como a aplicabilidade na literatura vigente. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Avante! Vamos lá então!!!

Quando falamos em prevenção, geralmente pensamos em comer bem, dormir 8 horas e se exercitar, e sem dúvida são elementos indispensáveis em nossa vida, mas há uma parte igualmente fundamental que é o monitoramento de nossa Saúde.

Estima-se que no Brasil mais de 10% das mortes anuais sejam causadas por doenças cardiovasculares, onde se destaca o diabetes mellitus, que segundo a OMS é evitável em 8 em cada 10 casos. (OMS, 2018)

Mas isso não é tudo, pois estima-se que pelo menos 80% não sabem que sofrem dessa doença, portanto as consequências são fatais.

Tendo em consideração estas informações preliminares, o cidadão preocupa-se com uma alternativa para essa melhoria. E aqui podemos

discorrer sobre o plano de saúde. Mas, afinal, o que é um plano de saúde?

É uma solução abrangente de proteção para atender às suas necessidades em questões de prevenção e grandes despesas médicas. Ter um plano de saúde oferece tranquilidade e segurança, protegendo seus ativos em caso de um evento imprevisto.

Agora, e a prevenção? O Seguro de Maiores Despesas Médicas protege o segurado quando já existe uma doença e, se considerarmos, por exemplo, que algumas doenças são controladas, mas não erradicadas, como doenças cardiovasculares, torna-se ainda mais importante ter instalações para o monitoramento da Saúde e, assim, prevenir.

Esse é o objetivo de um Plano de Saúde, que permite acessar coberturas como:

- análises clínicas;
- *check-ups*;
- consultas com especialistas, entre outros, sem a necessidade de sofrer uma doença ou exceder uma franquia; dando a você a oportunidade não apenas de monitorar seu estado de saúde, mas de melhorar sua qualidade de vida.

No entanto, vale destacarmos que antes de se contratar um plano de saúde, além de levar em consideração fatores como idade, sexo, localização e perfil socioeconômico, devemos refletir sobre nossas necessidades e as de nossa família.

Aconselhe-se, portanto, para tomar a melhor decisão, conhecer saiba os planos que eles oferecem, os valores segurados, franquias, despesas hospitalares, honorários de médicos e hospitais com os quais eles têm acordos médicos acordos, lista de médicos ...

Quando se trata de saúde, você deve ter todos as informações necessárias para adquirir o produto mais adequado para você, como por exemplo:

- **Comparar:** é importante que, antes de tomar a decisão final, você compare as opções no mercado, a taxa de cobertura de preço seja um fator importante na escolha.

- **Investir no futuro:** faça seu plano familiar e escolha o produto que melhor se adapte à sua situação financeira e às suas necessidades.

Já no que tange aos benefícios de ter um plano de saúde, é possível destacarmos de acordo com CONASS (2007):

- Para lidar com eventos imprevistos relacionados à sua saúde ou à de seus familiares.
- Não afeta a economia familiar em caso de doença ou acidente.
- Dá a você a oportunidade de cuidar de sua saúde e evitar doenças que podem ser prevenidas.
- Você pode aproveitar os benefícios mesmo sem estar doente.

NOTA



Antes de contratar qualquer plano, verifique o nível de rede que o provedor ou a seguradora possui, sua força financeira e a experiência que possui. Além disso, avalie o custo-benefício do produto, conheça a cobertura, benefícios e custos adicionais. Leve em consideração que a cada ano as taxas sobem, não se deixam levar pelo menor custo, pois isso pode aumentar consideravelmente. Encontre um plano personalizado.

Por outro lado, o conceito internacional de planos de saúde está relacionado aos planos de seguros privados (ilustração na figura 1) de assistência à saúde, considerado como uma atividade econômica e na literatura internacional referenciado como *HEALTH INSURANCE*.

Figura 1 – Ilustração de planos de saúde



Fonte: @freepik

Na classificação referenciada acima, faz parte também os seguros de acidentes, de incêndio, viagem, transportes e exclui os seguros de vida. O CPC (Classificação Internacional de Produtos) em conjunto com a ONU (Organização das Nações Unidas), definiram os produtos e serviços de seguro de saúde, que inclui:

- a) O seguro para cobertura das despesas médicas e hospitalares não cobertas por programas de governo e, usualmente, outras despesas de itens como medicamentos, aparelhos, ambulância e enfermagem;
- b) O seguro para cobertura de despesas odontológicas;
- c) O seguro que provê pagamentos periódicos no caso de o indivíduo ficar incapacitado para trabalhar como resultado de doença ou acidente.



IMPORTANTE

O ser humano é sempre propenso a acidentes e doenças de todos os tipos e em todos os níveis. E, às vezes, atender a alguns deles é muito caro e pode gerar muitos problemas financeiros. O seguro de despesas médicas busca ser um equilíbrio nisso.

Em relação aos planos de saúde privados, esses são internacionalmente denominados como *Private Health Insurance* (PHI). A Federação Internacional de Planos de Saúde incorpora centenas de empresas de saúde situadas em mais de 20 países. Até o final de 2013, não havia nessa federação empresas brasileiras, contudo, a partir da compra da Amil, empresa brasileira de planos de saúde privado, pela empresa norte americano *United Health Care* o Brasil se insere indiretamente a esse rol de empresas na federação.

Regulado pela Lei 9.656/1998, os planos de saúde no Brasil incluem em seu escopo operadoras de planos privados de saúde.

Figura 2: Planos de saúde



Fonte: @pixabay.

Oficialmente, é o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), que classifica as estatísticas sobre a quantidade de operadoras de planos privados de saúde no Brasil. O CNAE classifica as operadoras em dois grupos Seguro Saúde, CNAE 652 e Planos de saúde CNAE 655.

Importante destacar que dentro dessas duas classificações do CNAE, há uma lista de atividades de subclasses, como por exemplo, médico, odontologistas e médico veterinário. Para que o exercício das atividades possa ser fiscalizado, a Lei n. 6.839/1980 orienta:

- a) as operadoras de planos de saúde, de assistência médica ou odontológica, conforme definido pela mencionada Lei 9.656/1998, tem como requisito o registro nos Conselhos Regionais de Medicina e de Odontologia, conforme o caso.
- b) as empresas de planos de saúde animal têm como requisito o registro nos Conselhos de Medicina Veterinária

Os planos de saúde no Brasil são classificados de acordo com as denominações internacionais.



IMPORTANTE

Seguros: O que eles cobrem? As coberturas variam de acordo com a empresa que você contrata. Por exemplo, no caso de acidentes, algumas políticas oferecem não pagamento dedutível em caso de acidente.

- c) Tipologia de seguro de saúde;
- d) Classificação do papel dos seguros privados de saúde.

A definição da modalidade do seguro e saúde no Brasil, é feita pela forma de atendimentos que podem ser realizados de duas formas:

- e) Grupos definido, chamados de pooling.
- f) Financiamento e gastos por meio de quotização no tempo (pré-pagamento)

Nas duas formas descritas acima, o pré-pagamento da utilização dos serviços pelo usuário pode ser realizado por meio de recolhimento

que podem ser coletados antes, ou por meio de administração de recursos pela operadora.

Quadro1: Critérios de classificação dos seguros de saúde.

Critério	Taxonomia
Fonte de financiamento	Público ou privado
Obrigatoriedade do esquema	Voluntário ou Obrigatório
Esquema	I) Coletivo (de grupo): inclui esquemas de empregados de empresas. II) Individual: não se aplicam a grupos específicos.
Método de cálculo dos prêmios dos seguros	I) Baseado na renda: é o caso dos esquemas de "seguro social", no qual as contribuições são calculadas com base na renda do indivíduo, independentemente do risco de utilização dos serviços. II) por grupos (community rated): são ajustados pelo risco médio do grupo, de modo que todos os participantes pagam o mesmo prêmio. Pode contemplar fatores de ajustes do prêmio, como no caso de uma carga no prêmio para entrantes tardios no grupo. III) diretamente a partir do risco do indivíduo (<i>risk-rated</i>): relacionados ao risco individual e calculados a partir de princípios atuariais, com base na expectativa de utilização de serviços de saúde.

Fonte: CONASS (2007, p. 37)

Dentro dessa estrutura, enquadra-se as possibilidades de desembolso direto, co-pagamentos e co-participações pelos usuários.

A classificação dos planos privados de saúde no Brasil pode ser na seguinte categorização.

- a) Obrigatório individual
- b) Grupo de empregados

- c) Prêmios calculados por grupo (community rated) (Ex.: seguro de saúde voluntário na Irlanda e na Austrália). d) Prêmios calculados pelo risco do indivíduo (risk-rated). (Ex.: seguro privado de saúde no Reino Unido).

No Brasil, o SUS (Sistema Único de saúde) coexiste com seguros privados de saúde. Pela OCDE, o SUS é classificado como um seguro público, mantido por meio de recolhimento de impostos compulsório. Provê cobertura integral de serviços de saúde, sem co-pagamento.

Figura. 3 – Setor público x setor privado



Fonte: Ana Djéssika Vidal

Quando falamos de saúde suplementar no Brasil, identifica-se certa imprecisão na utilização dos conceitos de suplementar e complementar.

Complementar e suplementar são adjetivos antônimos. 'Complementar' refere-se aquilo que falta para um todo; enquanto 'suplementar' aquilo que excede o todo. Ao dicionário, temos: "Complementar: (adj. 2 gêneros) que serve de complemento; v. tr. completar. Suplementar: (adj. 2 gêneros) adicional; que amplia". (Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. 11a edição. Ed Gamma.) Frequentemente,

entretanto, o setor de saúde suplementar no Brasil é chamado de complementar” (Werneck, 2010, p.8).



NOTA

Porém, em geral, o seguro de despesas médicas mais altas cobre hospitalização, assistência médica, intervenções cirúrgicas, medicamentos e análises clínicas, entre outros serviços profissionais. Isso dependerá da companhia de seguros e do plano que você contratar.

Identifica-se que essa imprecisão já ocorre mesmo antes da Lei 9.656/98 em que se utilizavam os termos “atenção médica supletiva” e outros utilizavam “assistência médica complementar”. Da forma como se configura o SUS, o termo complementar se refere a atividade que envolve a operação dos planos privados de saúde.

Histórico e Fundamentação dos Planos de Saúde no Brasil

As características específicas de cada sistema de saúde dependem da história e das condições políticas e socioeconômicas de cada país, bem como do grau de influência exercido pelos vários grupos de interesse e do jogo das forças políticas.

A história da criação e desenvolvimento de sistemas de saúde está intimamente ligada à evolução dos regimes de proteção social no contexto do estado de bem-estar social, que surgiu no mundo ocidental desde o início do século XX e atingiu sua máxima expansão durante o período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial.

A institucionalidade e a estrutura dos sistemas de proteção social variam significativamente em termos de relações entre o Estado, o mercado, a sociedade e a família. As modalidades operacionais do Estado benfeitor exerceram grande influência no desenvolvimento dos sistemas de saúde.

No entanto, os modelos organizacionais correspondem a tipos ideais e não são apresentados em estado puro na realidade, de modo que nenhum deles foi totalmente aplicado pelos países. Pelo contrário,

a incorporação de versões parciais deu origem a diferentes universos institucionais, com arranjos organizacionais separados de condução / regulamentação, financiamento / garantia e prestação de serviços.

Em resumo, os sistemas de saúde baseavam-se em modelos ocidentais de proteção social, mas, diferentemente dos modelos estabelecidos na maioria dos países europeus, os subsistemas latino-americanos eram orientados para estratos específicos da população, agrupados por classe social, renda, ocupação, inserção no mercado formal de trabalho, origem étnica ou condição urbana ou rural, que produziu um fenômeno de segregação populacional que consiste na estratificação do exercício do direito à saúde.

Por esse motivo, a estrutura organizacional tradicional dos sistemas de saúde da América Latina consistia em um arranjo não integrado de subsistemas voltados para estratos específicos da população, o que levou a uma maior segmentação e fragmentação e afetou profundamente seu desempenho.

Os sistemas segmentados apresentam diferenças marcantes em termos de garantia de direitos segurados, níveis de despesa per capita e grau de acesso a serviços por diferentes estratos da população, uma reitoria fraca caracterizada por um quadro regulatório e supervisão insuficientes custos de transação inadequados e altos.

Eles também mostram regressividade e financiamento insuficiente, com predominância de pagamentos diretos ou diretos, com riscos catastróficos para a segurança financeira das famílias. As redes de provisão de serviços foram estabelecidas por cada subsistema, com integração e comunicação limitadas entre as unidades de assistência que as formaram, tanto no mesmo subsistema quanto entre os diferentes subsistemas e para os diferentes níveis de complexidade.

Além disso, a prestação de serviços concentrava-se principalmente nas áreas urbanas mais ricas e na população assalariada, e isso resultou em um uso ineficiente de recursos setoriais que deixaram os mais pobres, o setor informal da economia e, em muitos países, desprotegidos, a grupos indígenas, afrodescendentes e populações rurais e urbanas-marginais.

Vale mencionarmos que em alguns outros países da região, tais como Chile, Costa Rica e Cuba, foram introduzidas mudanças para quebrar as barreiras que separam esses vários mundos institucionais, mas a separação persiste na maioria deles e seus sistemas de saúde mostram altos níveis de segmentação e fragmentação, com a consequente segregação populacional.

Bem, visto isto, é importante mencionarmos que segundo a ANS (Agência Nacional de Saúde), as atividades que envolve os dos planos de saúde ou seguros de saúde chama-se Saúde Suplementar.

DEFINIÇÃO



"Saúde Suplementar" surge na década de 60 no Brasil por meio de influências do crescimento econômico e a estruturação a prática do trabalho formal. Somente no final da década de 90 que a atividade relacionada aos planos de assistência médica foi regulamentada pela Lei 9.656/98 e em 2000 criou-se a ANS (Agência Nacional de Saúde) para regulamentar, criar e implementar normas, além de realizar fiscalização das atividades relacionadas a planos de saúde no Brasil.

Trajatória dos Planos de Saúde no Brasil

As atividades relacionadas às práticas de saúde com a população no Brasil começam a estruturação em paralelo ao crescimento econômico. O grande "boom" econômico provocado pelo governo de Getúlio Vargas, estimulou a contratação formal de trabalhadores e a prática do cuidado em saúde é conduzido pelas empresas junto ao seu quadro de empregados.

Nesse cenário de desenvolvimento político e público em saúde brasileiro, surge o INAMPS (Instituto Nacional de Assistência médica da Previdência Nacional), a fim de acompanhar e regular a prática médica e sua relação com a previdência no país. Isabela Soares Santos, 2009, p.45.

A proposta de transformação do modelo da atenção à saúde foi favorecida uma vez que representou uma alternativa para o sistema de saúde brasileiro à crise econômica e à previdenciária pela qual o país passava. Assim, diversas mudanças ocorreram no setor de saúde, como a implantação das Ações Integradas de Saúde, AIS, em 1982, a realização da 8a Conferência Nacional de Saúde (8a CNS) em 1986, a qual subsidiou os Constituintes na elaboração da Constituição Cidadã e, ainda, a criação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, SUDS, em 1987.

Autores como Donnangelo (1975) e Cordeiro (1984), afirmam que a "Indústria da saúde, ou capitalização da saúde, surgem como resposta a uma estrutura de saúde que se fazia necessária junto aos trabalhadores. Além disso, essa prática organizada e estruturada de assistência médica nas empresas, foi impulsionada pelo formato de trabalho dos profissionais de saúde, em específico os médicos, que possuíam o controle de seu meio de trabalho. A partir de então, as formas de conquistados trabalhadores em relação ao acesso a saúde era algo impossível de retroceder.

Mudanças Políticas na Saúde Brasileira

Segundo Rodrigues e Santos (2011, p.75), as principais mudanças políticas em saúde brasileira são:

Quadro2: Mudanças políticas e do modelo de saúde pública no Brasil.

Marco Político	Modelo de saúde pública	Características do modelo de saúde pública
1930: Revolução (poder ligado à indústria)	1933: Criação dos IAPs	Seguro Social: a) organizado separadamente por categorias profissionais (IAPs específicos), b) financiado por contribuições os trabalhadores e empregadores com base na folha de salários, c) administrado por representantes dos trabalhadores e empregadores.
1964: Golpe militar	1966: Criação do INPS	Seguro social unificado: a) todas as categorias são seguradas pelo INPS, b) financiado por contribuições dos trabalhadores e empregadores, com base na folha de salários, c) administrado pelo Estado e representantes dos trabalhadores e empregadores.
1985: Fim do regime military	1988: Criação do SUS	Público de acesso universal: a) voltado para todos os cidadãos, b) financiado por toda a sociedade por meio de tributos, c) administrado pelo Estado.

Fonte: Rodrigues e Santos (2011, p.75). (Acesso em 17 de janeiro de 2020)

Em relação a história inicial dos planos de saúde como uma estrutura de tratamento a saúde no Brasil, segundo a ANS eles tem origem no século XVI ainda no período colonial com o surgimento das Santas Casas e somente no século XX que essa prática em saúde deixa

de ter caráter assistencial para se tornar uma atividade com cunho de exploração econômica.

Os planos de saúde têm origem na fundação das Santas Casas de Misericórdia, instituições vinculadas à Igreja Católica com forte apelo às ações caritativas e filantrópicas. Inicialmente internavam pessoas com vários tipos de doenças, menos as infectocontagiosas. As Santas Casas atuaram como principais prestadoras de serviços hospitalares no país, desde o período colonial, passando pelo Império, República Velha e estendendo-se até o Estado Novo, na primeira metade do século XX. As oportunidades de exploração econômica da assistência à saúde surgiram na década de 30 aqui no Brasil. E tiveram um crescimento no final da década de 50, quando o país iniciou o processo de industrialização, com a instalação das fábricas na região do ABC Paulista. Nessa ocasião, as instituições hospitalares privadas consolidaram-se como as principais prestadoras de serviço à classe média emergente (ANS, 2013).

Segundo a ANS, a construção do modelo que conhecemos hoje como planos de saúde, tem como pano de fundo as atividades assistenciais das Santas Casas (ilustração na figura 4) que mais tarde estruturaram-se novas formas de prestação de serviço em saúde no Brasil.



Fonte: [@freepik](#)

Além disso, abaixo, mencionaremos a respeito das características da trajetória da saúde suplementar no Brasil, sintetizando-as para o seu melhor aprendizado. Vejamos no quadro 2:

Quadro2: Características da trajetória da saúde suplementar no Brasil

Período	Ambiente macroeconômico	Ambiente regulatório	Evolução da saúde suplementar
Até 1965	Crescimento com aumento do trabalho formal	IAPs e lei Orgânica da Previdência Social	Limitada a grandes empresas e instituições públicas (autogestão)
1966 - 1980	Crescimento com aumento do trabalho formal	Incentivos/ subsidies ao crescimento do setor privado	Forte crescimento (principalmente medicina de grupo)
1981 - 1993	Crises e planos antiinflacionários	Reforma sanitária, Constituição, SUS (universalização excludente)	Forte crescimento (mercado formal)
1994 - 2007	Estabilização, baixo crescimento, retração de trabalho formal	Privatizações, abertura da economia, regulação	Estagnação, foco nos individuais (1994-1999), nos coletivos (2000-2007)

Fonte: Cechin (2008, p. 79).

A partir da década de 20 do século XX, os serviços de saúde prestados pelos CAPs (Centro de Atenção Psicossocial) e em seguida assumido pelos IAPs (Instituto de Aposentadoria e Pensões), iniciaram a construção de hospitais próprios.

Na sequência, as indústrias nos países despontam com iniciativas em relação ao cuidado à saúde do trabalhador, Francisco Carlos da Silva Araújo (2000, p.10)

Os IAPs descenderam das Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs), que, instituídas pela Lei Elói Chaves, de janeiro de 1923, ofereciam o benefício da aposentadoria a muito poucos trabalhadores. As CAPs se organizavam por empresas ou empregados, em regime de capitalização, mas, dizem, como tinham poucos contribuintes e muitas fraudes, não pareciam capazes de sobreviver por muito tempo.

Alguns marcos históricos da política de saúde no país podem ser destacados:

- a) Incorporação da assistência sanitária à Previdência Social em 1946 e em 1949 a criação do SAMDU (Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência da Previdência Social)
- b) Em 1960, a Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS) uniformizou as regras dos IAPs, incluindo os benefícios concedidos, a forma de contribuição para o financiamento do sistema e os procedimentos administrativos dos institutos.

Até 1960, a cobertura de atendimento à saúde do brasileiro era restrito aos empregados, principalmente àqueles contratados pelas grandes empresas públicas e privadas. E é a partir desse período que se tem como marco o surgimento dos planos de saúde no Brasil.

"A saúde suplementar surge com a industrialização do Plano de Metas de Juscelino Kubitschek. Era importante que os trabalhadores das novas indústrias tivessem tratamento rápido e eficaz em caso de doença. Tratava-se de reduzir o absenteísmo e manter a produtividade, por meio de cuidados imediatos e resolutivos aos trabalhadores adoecidos. As empresas multinacionais que aqui se instalaram trouxeram as experiências dos países de origem. O setor público não estava equipado para o tratamento necessário; os serviços

prestados pelas Santas Casas de Misericórdia destinavam-se prioritariamente aos mais pobres e sem alternativas. Assim, o setor de planos e seguros de saúde nasceu e se desenvolveu junto com a economia do país. Mesmo a perda de dinamismo da economia a partir da década de 1980 não alterou muito a tendência de crescimento do setor. Havia um mercado a conquistar, pois ainda era baixa a taxa de cobertura mesmo entre as camadas mais bem posicionadas no mercado de trabalho, no que o setor também foi auxiliado pela crescente formalização do emprego até o fim da década" (Cechin, 2008, p. 17).

Nesse cenário de crescimento econômico com a entrada maciça da industrialização, existe interesse em explorar economicamente a prática da saúde no país, apoiados pelas que visava dar cobertura para um número maior de pessoas, apoiadas pelas políticas previdenciárias privadas e a intensa atuação de associações médicas.

No caso brasileiro, o surgimento dos planos de saúde se dá principalmente em cidades com grandes empresas, privadas ou públicas. Esse mercado empresarial surge com os primeiros convênios de grandes empresas, a maioria multinacional, em São Paulo e se consolida nas décadas de 50 a 70 (Salm, 2005, p. 14).

O destaque a São Paulo se dá com a instalação da indústria automobilística no ABC paulista, o que gerou uma demanda de proteção à saúde mais orientada aos trabalhadores das multinacionais.

Modalidades de Operadoras e Resultados Econômicos

Em convênio com as grandes indústrias, em 1960 surge o grupo de cooperativas médicas. Bahia (1999, p.187) destaca:

1. as medicinas de grupo, inicialmente voltadas exclusivamente para os clientes empresas, emergem a partir do convênio da Policlínica Geral com a Volkswagen; ii) as cooperativas médicas, voltadas principalmente para planos coletivos, mas também com o início dos planos individuais, emergem a partir da primeira Unimed, a de Santos, e de seu contrato com a Union Carbide em Cubatão. Bahia (2005, p.31) mostra que a oposição das entidades médicas às empresas lucrativas de planos de saúde, fez emergir, em meados dos anos 1960 as empresas de planos de saúde não lucrativas, principalmente sob os quatro formatos abaixo: i) voltadas para hospitais filantrópicos, cujo maior exemplo é a
2. Senasa, criada em 1963, que viria a originar a Golden Cross; 2) Sociedades médicas de caráter beneficente, tal como a Interclínicas, fundada em 1968 e constituída por 4 instituições não lucrativas; 73 Inicialmente, a difusão das cooperativas médicas e das empresas de medicina de grupo foi maior nas cidades do Estado de São Paulo. Em 1969 foram criadas 30 cooperativas médicas em cidades paulistas e, segundo a Unimed do Brasil, em 1977 existiam 60 cooperativas no país, a maioria sediada em cidades do interior de São Paulo. Em 1973, São Paulo concentrava 100 dos 132 grupos médicos registrados pela ABRAMGE, enquanto no Rio de Janeiro atuavam 11. (Bahia, 1999) 86

Cooperativas compostas por médicos oriundos de instituições já existentes (empresas de planos de saúde lucrativas, Santas Casas, hospitais privados e entidades médicas, com exemplos como Medilar e Pré-Médica);

3. as primeiras cooperativas de trabalho médicos, sob o nome de União dos Médicos (Unimed). A mesma autora (Bahia, 2005, p.31-32) aponta que dentre essas alternativas, viabilizaram-se somente as cooperativas médicas e algumas das empresas de planos de saúde não lucrativas. O espectro de alternativas às empresas lucrativas dos planos de saúde ficou reduzido em função, por um lado, dos gastos com credenciamento universal e a livre escolha e as dificuldades de classificar os estratos da população, e, por outro lado, os obstáculos à regulamentação das cooperativas e entidades filantrópicas.

As Unimeds tornaram-se planos de saúde com uma rede assistencial baseada nos consultórios particulares dos médicos, com acelerada expansão nas cidades brasileiras de grande e médio porte. Essa expansão fez refrear o desenvolvimento das medicinas de grupo que se dava por meio da construção dos ambulatorios e do assalariamento dos médicos.(Bahia, 2005, p.32) A despeito das diferenças e concorrência entre as cooperativas médicas e as medicinas de grupo, muitos analistas tratam de forma semelhante as duas entidades, uma vez que, nos anos 1960 e 1970, ambas adotaram a mesma forma de financiamento, os planos de pré-pagamento, além disso, pelo fato de serem caracterizadas pela presença de médicos como seus proprietários ou associados (Bahia, 2005, p. 33-34).

4. Medicinas de Grupo: criadas por proprietários / sócios de hospitais;
5. Cooperativas Médicas: Conforme ilustração da figura, estas foram criadas por profissionais vinculados a entidades profissionais. Essas duas modalidades adotaram, inclusive em função das regras dos convênios com a Previdência, o credenciamento de serviços para a complementação de seus recursos originais, que eram principalmente os hospitais 87 no caso das Medicinas de Grupo e os consultórios médicos no caso das cooperativas (Bahia, 2001b, p.328), num contexto em que os capitalistas individuais ou os da área bancária e financeira não apoiavam a medicina empresarial.

Figura 5: Equipe de Saúde



Fonte: @freepik

Em 1974, as questões sociais ressurgem no Brasil como reflexo do contexto político. O “milagre econômico” enfraquece e retrocede e algumas medidas são tomadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Criou-se nesse período o PPA (Programa de Pronta Ação) que determinava regras para prestação dos serviços médicos previdenciários. O Estado universaliza o sistema público e transfere as funções para a iniciativa privada. Werneck Vianna, 1998, p.19 explica essa segmentação:

(...) conforme a segmentação a seguir explicada pela mesma autora: a) Hospitais próprios da Previdência - reservados para o atendimento altamente especializado, a pesquisa e o aperfeiçoamento, b) Convênios com empresas, com outras instâncias da União ou com os governos estaduais e municipais, além do credenciamento de médicos particulares ou contratos de serviços com cooperativas médicas - responsáveis pela ampliação da assistência médica em geral, c) Estabelecimento do direito ao atendimento emergencial gratuito, garantindo-o a qualquer pessoa, segurado ou não da Previdência. No Brasil dos anos 1970, havia quatro alternativas assistenciais contratadas coletivamente, como indica Bahia

(2001b, p.328): a) As empresas com planos próprios, b) A rede de serviços próprios e credenciados pelo INPS, c) Os serviços próprios e credenciados das empresas médicas, e d) Os credenciados para atender os trabalhadores rurais.

A universalização do atendimento emergencial gratuito acabou estrangulando o sistema de assistência de saúde, fato esse que influenciou a população com maior renda na direção dos planos de saúde. Assim se insere o conceito de universalização excludente. Faveret e Oliveira (1998, p.169) destacam:

"No caso brasileiro podemos supor a existência de um processo de universalização excludente, em que cada movimento de expansão universalizante do sistema [de proteção social] é acompanhado de mecanismos de racionamento (queda na qualidade dos serviços, filas, etc.) que expulsam daqueles diversos segmentos sociais".

Inicia-se de forma mais branda a partir de então o conceito de universalização excludente. A estrutura de convênio-empresa se propaga e poucos são os brasileiros que conseguem acessá-los por seus altos custos. Em contrapartida, os recursos escassos e a alta demanda de pacientes acabam depredando e provocando gradativamente a baixa qualidade dos serviços prestados pelo INAMPS.

O INAMPS nesse processo de ajustes opta por restringir a participação de novos convênios-empresas, criando exigências para novos credenciamentos. A desvalorização do INAMPS inicia-se ao final de 1970, ele não era mais interessante nem para os médicos, nem para as empresas, pois a participação do mercado já não estava nas mãos do INAMPS.

Segundo Cechin e Badia (2008, p. 1),

(...) o mercado de planos de saúde apresenta expansão significativa do final dos anos 1950 até 1980, quando alcançou aproximadamente 15 milhões de beneficiários⁸², distribuídos entre 300 operadoras. Os mesmos autores apontam que mesmo com a crise do início dos anos 1980, o setor continuou a crescer nessa década.

Em 1980, o INAMPS sofre sérias dificuldades financeiras e rompe com muitos contratos e convênios com hospitais. Abaixo, na figura 6, podemos observar a charge referente à saúde na UTI.

Por outro lado, devemos destacar que do período de 1975 a 1979 houve uma grande evolução dos convênios-empresas. Vejamos na ilustração do quadro 3 abaixo:

Tabela 3: Evolução dos convênios-empresa 1975-1979

Ano	N. de convênios	População coberta (em milhares)
1975	3.096	3.572
1976	4.069	4.291
1977	4.929	4.599
1978	5.312	4.826
1979*	5.840	4.941

Fonte: Braga e Paula, 1986, apud Werneck Vianna (1998, p. 282).

Marco Regulatório Setorial (1985-1998) – Implantação da Saúde Universal e Consolidação do Mercado Suplementar

A partir de 1985 o Brasil se mobiliza para um movimento que pede uma reforma em busca da implantação de um sistema de saúde universal. Em 1987, entra em vigor o SUS (Sistema Único de Saúde) que oferecia acesso universal a saúde sem distinção (figura 8) para atendimento médico entre segurados e não segurados pela previdência social.



Fonte: [@freepik](#)

Em 1988, com a Constituição, a saúde fica garantida a todo cidadão brasileiro, identificado no artigo 196 - "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" art 196, Constituição 1988.

A partir dessas mudanças cria-se o SUS que em seu processo de implantação enfrenta dificuldades e com elas algumas mudanças

relacionadas as políticas de assistência médica, tais como Werneck Vianna (1998, p.151-152) aponta:

- 1.** O estabelecimento de um sistema de saúde bastante avançado em termos de cidadania; no entanto "o Estado se comporta como um ator cujas não decisões geram consequências opostas ao seu próprio discurso"
- 2.** Ao abdicar das funções mediadoras e sobretudo normativas, o poder público não só deixou que o mercado de serviços médicos prosseguisse como diminuiu sua capacidade de regulá-lo.

Com um processo claro de deterioração do atendimento público, em que a qualidade dos serviços prestados fica à margem do mínimo esperado, aumenta a segmentação de clientes para planos privados.

Andrade e Dias Filho (2009, p.163) identifica que na década de 80, no Brasil, a responsabilidade sobre a gestão de saúde do trabalhador formal ficou nas mãos dos planos de saúde privados e pagos.

Nessa perspectiva, o mercado da assistência privada no Brasil tornou-se um diagrama crescente, onde passou a ser exercido por vários agentes privados que, através do pagamento de um valor específico, podem utilizar do serviço de saúde vinculado ao plano selecionado.

Ressalta-se ainda que, vinculado a este serviço de saúde que comumente é denominado de plano de saúde, ainda se observa a presença dos prestadores de serviços como é o caso de hospitais, profissionais da área de saúde e laboratórios. Sendo assim, torna-se possível observar a presença de uma relação tríade entre: prestadores de serviços, o intermediador e, por fim o usuário.

Figura 7 – Três componentes dos planos de saúde



Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

Todavia, com o intuito de proteger os interesses das partes envolvidas neste processo de prestação de serviços de saúde, não se pode deixar de mencionar a importância da regulamentação das atividades neste processo de relação de consumo pela ANS (Agência Nacional de Saúde). Por isso, torna-se de substancial importância que a empresa que se deseja contratar esteja devidamente registrada no órgão acima referido.

Dentro das atribuições relativas às atividades desenvolvidas pela ANS, convém ressaltar a definição das diretrizes que podem ser executadas pelos planos de saúde e, ainda, de suas obrigações. Nesse sentido, observa-se, portanto, que a ANS estabelece a política dos direitos e deveres tanto no âmbito do usuário como também, dos planos de saúde.

Sendo assim, a agência nacional de saúde define uma listagem de condutas (procedimentos) e processos que os planos de saúde devem oferecer, ou seja, por lei existe uma obrigação jurídica de fazer para que o direito de acesso à saúde seja, efetivamente, cumprido.

Destaca-se ainda, que para determinados processos, os planos que estiverem sido contratados anteriormente ao ano de 1999, existe algumas exceções, ou seja, o plano de saúde não é obrigado a oferecer o serviço, desde que o contrato do usuário não tenha migrado às novas diretrizes. Por isso, é comum que casos em que envolvam órteses e próteses sejam excluídos da cobertura de determinados planos de saúde, visto os contratos não estarem regulamentados pela Lei 9656/98.

Por isso, torna-se importante observar que, o processo de contratação de um determinado plano de saúde deve ser precedido de uma consulta prévia acerca do tipo de assistência que será recebida a partir da contratação do plano, visto que, o tipo de assistência irá depender do tipo de contrato que for assinado pelo usuário. Essa questão é denominada de segmentação do serviço e a depender do tipo de plano contratado, será possível identificar a cobertura intrínseca ao contrato e isso inclui, a abrangência do serviço a ser prestado.

Nessa perspectiva ainda cabe a indicação de quais normas se aplicam ao funcionamento dos planos de saúde, nomeadamente o Código de Defesa do Consumidor- Lei Nº 8.078/90; Resolução Normativa da ANS nº 226 (5/8/2010); Lei dos Planos de Saúde – Lei 9.656/98 e a Lei de criação da ANS: 9961/2000.

Dentro da base normativa que se destina a regulamentação dos planos de saúde, observa-se a existência de planos com cobertura integral, cobertura segmentada e, por fim, cobertura superior. O quadro ilustrado na figura 8 que será apresentado ao final da unidade apresentará de maneira específica a compreensão para cada tipo de plano no que tange aos serviços contratados.



SAIBA MAIS

A defesa do consumidor no Brasil se desenvolveu a partir da década de 1960, quando foi reconhecida a vulnerabilidade do consumidor e sua importância nas relações comerciais nos Estados Unidos. Leia mais em: <https://bit.ly/3ignxfM>

A diferença entre as espécies de coberturas acima mencionadas reside tão somente nos tipos de serviços que serão prestados. Portanto, caso o usuário opte pelo plano de saúde com cobertura integral estará incluso, nessa perspectiva, plano ambulatorial + o hospitalar (podendo ser com ou sem obstetrícia). Convém observar ainda que, ao se tratar de plano com cobertura integral seria uma cobertura mais ampla do que a segmentada, pois irá abranger de maneira acoplada o serviço ambulatorial, odontológico e hospitalar.

Ao se tratar dos serviços segmentados, identificou-se a questão relacionada com o sistema ambulatorial que nada mais é do que procedimentos eivados de menor complexidade, onde o profissional da saúde irá realizar atividades primárias em usuários que buscam o serviço com algum tipo de queixa. O atendimento ambulatorial pode servir como um tipo de complemento aos atendimentos que foram prestados nas urgências.

Na atividade ambulatorial é possível ao paciente realizar não apenas o atendimento complementar prestado pela urgência, mas também a realização de determinados exames clínicos e, ainda de imagem, como é o caso da tomografia, laboratório, radiografia, ultrassom. Sendo assim, percebe-se que no serviço ambulatorial se encontra (ou deveria se encontrar) os usuários que não apresentam nenhum quadro de alta gravidade, ou seja, situações que dispensam algum tipo de internação.



Por isso, o serviço ambulatorial é bastante usado pelo usuário em momentos de realização de exames de rotina, sem que exista nenhum tipo de doença identificada. Entretanto, não se pode deixar de observar que, em muitas situações, na realização de exames de rotina, torna-se possível identificar algum tipo de doença, muitas vezes, doenças graves.

Nesse sentido, tendo compreendido o sistema de funcionamento dos serviços ambulatoriais, observa-se que não podem ser considerados integrados nessa classe as internações hospitalares e procedimentos que dependam do apoio hospitalar que exijam um período superior a 12 horas, como é o caso da aplicação de anestesia. Os serviços ambulatoriais não se aplicam também aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica, bem como processos e procedimentos que necessitem de auxílio hospitalar para internação, como é o caso da quimioterapia e a radioterapia, exames radiológicos invasivos, a nutrição parenteral (por exigir um procedimento específico e especializado).

No caso de o usuário optar pela cobertura hospitalar é possível ser observado que os serviços que poderão ser executados relacionam-se exclusivamente com aqueles realizados dentro do ambiente hospitalar e, portanto, não dão cobertura aos processos e procedimentos realizados fora do hospital.

Com a exceção de exames que se destinam aos pacientes com obesidade mórbida, excluem-se exames realizados em clínicas de estética. Outra exceção a esta regra no que se refere aos processos e procedimentos que envolvem córnea e rim. Dessa maneira observa-se, tão somente, que este tipo de plano com cobertura hospitalar se restringe tão somente aos procedimentos e processos que irão se realizando dentro do ambiente hospitalar.

NOTA



Se você quer ter maior conhecimento neste assunto, acesse: <https://bit.ly/3jc2TvB>. E leia mais sobre o manual do SUS que é destinado a gestores, prestadores e profissionais de saúde que atuam com os sistemas de captação de dados e com o processamento da informação do atendimento em saúde ao paciente internado na rede do Sistema Único de Saúde (SUS)

No caso da escolha do plano hospitalar com obstetria será identificada as mesmas restrições observadas no plano hospitalar, entretanto, a diferença reside tão somente na inclusão dos processos e procedimentos voltados para a gestação, ou seja, o pré-natal e o parto.

Convém observar, contudo, que existe um período de carência de dez meses que deverá ser obedecido para que seja possível a utilização do plano de saúde hospitalar com obstetria. Destaca-se ainda que, no presente plano de saúde, o recém-nascido tem direito a cobertura nos primeiros 30 dias e, ainda, o direito a inscrição no plano de saúde que a mãe está acobertada.

Contudo, no caso dos recém-nascidos, não existe a necessidade do cumprimento da carência quando da efetivação do plano de saúde após o fim dos 30 dias de cobertura a partir do plano de saúde da mãe. Nos casos de adoção, por ser considerado por lei, um vínculo permanente e real, os filhos que forem adotados e que tenham idade inferior a 12 anos, possuem os mesmos direitos de um recém-nascido.

Existem ainda, de maneira um pouco diferente dos planos de saúde individuais, os planos de saúde coletivos, em que não há nesse caso um contrato individual de prestação de serviços que fora escolhido pelo usuário, mas tão somente um plano de saúde que foi contratado por empresas com o intuito único de dar a cobertura de serviços de saúde voltados aos funcionários.

O presente tipo de plano de saúde pode ser considerado bastante vantajoso para as empresas, visto que pouco se discute sobre os interesses dos usuários, já que o interesse das empresas e dos prestadores de serviços acabam prevalecendo. E, por fim, de maneira distinta a que ocorre com os contratos individuais, os contratos que decorrem do plano em questão não proíbe de maneira expressa o cancelamento de maneira unilateral do contrato por parte das operadoras.

Figura 9 – Inclusão obrigatória e não-obrigatória

Consultas médicas, internação, CTI e todos os serviços necessários durante a internação, Consultas/sessões com os outros profissionais da saúde, Cirurgias por videolaparoscopia, Medicamentos imunobiológicos, procedimentos preventivos, bolsas coletoras, cirurgias menores odontológicas

•**Inclusão obrigatória**

Estética; Próteses; tratamentos ilícitos, inseminação artificial;
Tratamento experimental, fornecimento de remédio para
tratamento domiciliar

Fornecimento de órteses, casos de catástrofe

•**Não obrigatória**

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020), adaptado de WERNECK (2010)

No que se refere aos planos de saúde com cobertura superior, existe para além da previsão da inclusão dos serviços ambulatoriais e hospitalares, a possibilidade de internação em quarto superior com possibilidade de acompanhante. Ademais, neste plano é incluído também os processos e procedimentos estéticos.

SAIBA MAIS



Quer se aprofundar neste tema? Recomendamos o acesso à seguinte fonte de consulta e aprofundamento: Artigo: "**O mercado de planos de saúde no Brasil: uma criação do estado?**"(Reis, Andreazzi e Silveira, 2006) acessível pelo link <https://bit.ly/3jacoNm>

RESUMINDO



Por fim, as políticas públicas no Brasil influenciaram e promoveram a expansão dos planos de saúde no país. A partir do marco regulatório no século XXI com a criação da ANS, ocorreram mudanças para o mercado de saúde.

Medidas importantes regulamentaram os produtos oferecidos pelas agências de planos de saúde. Medidas que garantissem o cumprimento

de obrigações frente aos consumidores. Ao mesmo tempo, a ANS contribuiu continua contribuindo para que as agências de planos de saúde enriquecessem sem causa.

Destaca-se dentro das atividades de regulação financeira aplicada às agências de saúde, a determinação que obriga o plano de saúde o ressarcimento pelasadoras, os valores relativos a procedimentos utilizados pelo SUS por usuários cobertos por planos de saúde privados.

Após o marco regulatório implantado no Brasil, mudanças relevantes foram evidenciadas. Um exemplo dessas mudanças, também pode ser evidenciado na forma de controle sobre o aumento de preço das mensalidades e valores aplicados aos procedimentos médicos.

Com a evolução de a saúde suplementar no país, orientado e regulado pela ANS, resultou para o mercado a eliminação de várias empresas extinguindo àquelas que não conseguiram garantir a prestação dos serviços contratados não conseguiram se manter nesse ambiente competitivo

Pelas exigências financeiras para entrada no mercado, as agências de saúde suplementar se tornaram um setor de alto retorno, mas de alto risco.

BIBLIOGRAFIA

ANS. **Agência Nacional de Saúde**. Disponível em: <<http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/4466-ans-celebra-os-20-anos-de-regulamentacao-da-saude-suplementar>> Acesso em 17 de janeiro de 2020.

BAHIA, Ligia (1999). **Seguros e planos de saúde uma saída à brasileira: estudo da organização da oferta a partir de noções das teorias de seguros**. Rio de Janeiro. Tese de doutorado da ENSP/Fiocruz. Disponível em: http://www.ans.gov.br/portal/upload/forum_saude/forum_bibliografias/abrangenciadaregulacao/AA10.pdf . Acesso em jan.2020.

CONASS (2007). **Saúde Suplementar**. Coleção Progestores – Para entender a gestão do SUS, vol. 11. Brasília. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Disponível em: http://www.ans.gov.br/portal/upload/biblioteca/11_Saúde%20Suplementar.pdf . Acesso em jan.2020.

CULTBRASILIA. **Figura 7**. Disponível em: <www.cultbrasil.org> Acesso em 17 de janeiro de 2020.

CECHIN, Jose (org.) (2008). **A história e os desafios da saúde suplementar: 10 anos de regulação**. São Paulo: Saraiva Letras & Lucros. 2008. 286

-----, Jose; BADIA, Bruno D. (2008). **A história e os desafios da saúde suplementar**. Instituto de Estudos da Saúde Suplementar (IESS). Disponível em: http://www.iess.org.br/html/Artigo1_Livro_10%20anos.pdf . Acesso em jan.2020

CORDEIRO, Hésio A. **As empresas médicas: as transformações capitalistas da prática médica**. Rio de Janeiro: Graal, 1984.

IMEDIATO ONLINE. **Figura 4**. Disponível em: < www.imediatoonline.com.br>. Acesso em 17 de janeiro de 2020.

JUSTIÇA. **Direitos do consumidor.** Disponível em: <<https://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/a-defesa-do-consumidor-no-brasil>> Acesso em: 23 de janeiro de 2020.

PIXABAY. **Figura 2.** Disponível em: <<https://pixabay.com/pt/photos/m%C3%A3os-idade-idosos-antigo-s%C3%AAnior-578917/>> Acesso em 17 de janeiro de 2020.

POLITICA DINAMICA. **Figura 1.** Disponível em: <www.politicadinamica.com> Acesso em: 23 de janeiro de 2020

REIS, Andreazi. **O mercado de planos de saúde no Brasil: uma criação do estado?"** (2006). Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-98482006000100007> Acesso em 20 de janeiro de 2020.

RODRIGUES, Paulo Henrique; Santos, Isabela Soares (2011). **Saúde e Cidadania: uma visão histórica e comparada do SUS.** São Paulo, Editora Atheneu: 2011. 2a edição.

SANTOS, Isabela Soares (2009). **O Mix Público-Privado no Sistema de Saúde Brasileiro: elementos para a regulação da cobertura duplicada.** Tese de doutorado em Saúde Pública, ENSP, Fiocruz. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/premio2010/doutorado/trabalho_isabelas_santossantos_mh_d.pdf Acesso em JAN.2020.

SAÚDE NA UTI. **Figura 6.** Disponível em: <https://www.sobral24horas.com/2019/01/a-saude-publica-de-sobral-agoniza-na-uit.html>>. Acesso em 17 de janeiro de 2020.

SAÚDE SUPLEMENTAR Ana Djéssika Vidal Residente de Gestão Hospitalar – Economia Disponível em: <residecoadm.hu@ufjf.edu.br>. Acesso em 17 de janeiro de 2020.

TVJ. **Figura 5.** Disponível em: <www.tvj.com.br>. Acesso em 17 de janeiro de 2020

WERNECK, Heitor Franco (2010). **Os Seguros privados de saúde no Brasil: uma análise taxonômica a partir da OCDE.** Texto para discussão n. 02. Abril de 2010. Rio de Janeiro: ANS.

Livro Didático Digital

Milena Barbosa de Melo
Cristina Spengler Azambuja



TeleSapiens